

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Sciences • Tle A1 A2 A3 A4 A5 ABI

Les complications de la grossesse et la stérilité

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Ce TD de synthèse mobilise vos connaissances sur la physiologie de la grossesse, ses pathologies et les enjeux éthiques de l'AMP. Répondez de manière argumentée, en articulant données physiologiques et conséquences cliniques.

EXERCICE 1 Physiopathologie de l'éclampsie et du diabète gestationnel

Une primigeste de 28 ans consulte à 32 SA pour céphalées, troubles visuels et œdèmes des membres inférieurs. La TA est de 160/110 mmHg. La bandelette urinaire révèle une protéinurie à 3 g/24h. La glycémie à jeun est à 1,10 g/L (norme < 0,92 g/L).

1. En vous basant sur l'invasion trophoblastique anormale, expliquez le mécanisme reliant la mauvaise remodelage des artères spirales à l'hypertension artérielle et à la protéinurie observées. (4 pts)
2. Analysez l'origine physiopathologique de l'hyperglycémie chez cette patiente : rôle des hormones placentaires (HPL, cortisol, progestérone) sur la sensibilité à l'insuline maternelle. Pourquoi ce diabète apparaît-il préférentiellement au 3^e trimestre ? (3 pts)
3. Discutez les risques fœtaux immédiats (macrosomie, détresse, hypoglycémie néonatale) et maternels à long terme (diabète de type 2, récurrence) associés à ces deux pathologies combinées. (3 pts)

EXERCICE 2 Grossesse extra-utérine (GEU) : diagnostic différentiel et urgence vitale

Une patiente de 30 ans, porteuse d'un DIU au cuivre, présente une aménorrhée de 6 SA, des métrorragies foncées et des douleurs pelviennes unilatérales depuis 48h. L'échographie endovaginale montre une cavité utérine vide, une image annexaire hypoéchogène de 3 cm avec activité cardiaque, et un liquide libre en cul-de-sac de Douglas. β -hCG sérique = 4500 UI/L.

1. Justifiez le diagnostic de GEU rompue. Expliquez pourquoi la localisation tubaire (ampolaire) est la plus fréquente en reliant l'histologie de la trompe (absence de couche déciduale, vascularisation) à l'implantation anormale. (3 pts)
2. Interprétez la discordance entre le taux de β -hCG (seuil de visibilité échographique intra-utérine théoriquement 1500–2000 UI/L) et la cavité vide. Quel est le risque vital immédiat lié au liquide libre ? (3 pts)
3. Comparez la prise en charge chirurgicale (salpingectomie vs salpingostomie) et médicale (méthotrexate) dans ce contexte de GEU rompue avec hémopéritoine. Argu-

mentez le choix thérapeutique impératif ici. (4 pts)

EXERCICE 3 Bilan étiologique de l'infertilité et décision en AMP

Un couple consulte après 24 mois d'infertilité. Bilan : Homme : oligo-asthénospermie (OATS) sévère (concentration 5 M/mL, mobilité 15%, formes normales 2%). Femme : cycles réguliers 28j, température biphasique, hystérosalpingographie normale, dosage hormonal J3 (FSH, LH, Estradiol, AMH) dans les normes.

1. Classifiez les causes d'infertilité masculine (pré-testiculaire, testiculaire, post-testiculaire) et proposez deux explorations complémentaires ciblées pour étiologiser cette OATS sévère. (3 pts)
2. Au vu des résultats, l'équipe propose une FIVETE avec ICSI. Décrivez précisément les étapes de l'ICSI (Injection Intra-Cytoplasmique de Spermatozoïde) et expliquez pourquoi cette technique contourne les défauts de la fécondation naturelle observés en FIVETE classique chez cet homme. (4 pts)
3. Menez une analyse critique éthique de cette prise en charge : discutez le principe de non-malfaisance (risques épigénétiques, prématurité, grossesses multiples), le principe de justice (accès aux soins, coût pour la collectivité) et le devenir des embryons surnuméraires (congélation, don, recherche, destruction). (3 pts)

EXERCICE 4 Sensibilisation et santé reproductive : étude de cas programmatique

Dans le cadre d'une campagne de santé publique ciblant les grossesses précoces et les avortements à risque dans une zone rurale, vous devez concevoir un argumentaire pour des leaders d'opinion locaux.

1. À partir des complications étudiées (hémorragies, infections, perforations utérines, stérilité secondaire), construisez un tableau synthétique reliant 3 complications majeures de l'avortement clandestin à leurs mécanismes lésionnels et aux séquelles potentielles sur la fertilité future. (4 pts)
2. Rédigez un message de prévention court (max 150 mots) intégrant les notions de planification familiale, suivi prénatal précoce (dépistage GEU, éclampsie, diabète) et prise en charge des IST, adapté au niveau de littératie en santé de la population cible. (3 pts)
3. Discutez les limites éthiques et juridiques de la promotion de l'AMP (FIVETE) dans un contexte de ressources sanitaires limitées où la mortalité maternelle par hémorragie du post-partum reste élevée. (3 pts)